



3

55. ÅRGANG | 03 • 2018

ARTIKEL

PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK TIDSSKRIFT
FORLAGET SKOLEPSYKOLOGI • PÆDAGOGISKE PSYKOLOGERS FORENING

Indhold

Ensomhed hos børn og unge med autisme

Børn lærer og udvikler sig gennem hvordan deres deltagelse i forskellige praksissammenhænge spiller sammen

Inklusionens udfordring: Børn med usynlige handicap

Psykologen som konsulent i fælles refleksionsrum med rådsøger
– rettet mod udviklingspsykologisk praksisudvikling for børn i
bekymringsområder

Interaktionsobservation som grundlag for intervention omkring
førskelebarner med synsnedsættelse

Forudsigelse af alvorlige afkodningsvanskeligheder i 2. klasse på basis
af testresultater i 0. og 1. klasse

Professionel kompetenceudvikling og social ulighed i dagtilbud

Ensomhed hos børn og unge med autisme



Funderet i Kanners (1943) tidlige beskrivelser af "desired aloneness" (ønsket alenehed) hos børn med autisme har det været en udbredt opfattelse, at børn og unge med autisme ikke ønsker social kontakt, men derimod foretrækker at være alene. Nyere studier peger imidlertid på, at børn og unge med autisme ofte føler sig ensomme. Denne artikel giver en introduktion til et nyt forskningsfelt og belyser pædagogiske og psykologiske indsatser, der kan være virksomme i forhold til ensomhed hos børn og unge med autisme.

*Af Anne Sofie Bjerre Lunkeit, cand.psych ved Fonden Mødrehjælpen,
Mette Elmose, cand.psych., ph.d., adjunkt ved Institut for Psykologi,
Syddansk Universitet og
Mathias Lasgaard, cand.psych., ph.d., lektor ved DEFACTUM,
Region Midtjylland og Institut for Psykologi, Syddansk Universitet*

Autisme

Autismespektrumforstyrrelser (forkortet autisme) er en samlebetegnelse for en gruppe gennemgribende udviklingsforstyrrelser, der er karakteriseret ved sociale og kommunikative vanskeligheder, som kan hæmme etablering og vedligeholdelse af sociale relationer. (World Health Organization, 1994). Diagnosegruppen repræsenterer en høj grad af variation, hvor den kliniske præsentation inden for hvert symptomområde varierer i sværhedsgrad fra person til person. Et nyere amerikansk studie estimerer at autisme forekommer hos 1 ud af 68 børn i 8-års alderen (Christensen et al., 2016). Samme studie finder, at 32 % af børnene har en IQ under 70, 25 % har en IQ i grænseområdet (IQ=71-85), og 44 % har en IQ i eller over normalområdet (Christen-

sen et al., 2016). Graden af sociale og kommunikative vanskeligheder varierer desuden betydeligt mellem børn og unge med autisme (Anderson, Oti, Lord & Welch, 2009). I studier refereres ofte til højtfungerende og lavtfungerende autisme typisk med reference til det intellektuelle funktionsniveau. Betegnelserne højtfungerende og lavtfungerende kan dog nemt lede tankerne hen på et mere generelt funktionsniveau. Selvom IQ i en vis udstrækning påvirker det generelle funktionsniveau, kan specifikke vanskeligheder omkring social interaktion, kommunikation, sensoriske vanskeligheder eller anden samtidig psykiatrisk lidelse have en gennemgribende betydning for personens daglige funktionsniveau eller det sociale funktionsniveau (Anderson, Oti, Lord & Welch, 2009). Aktuelle

studier af ensomhed og relationer til jævnaldrende omhandler primært børn og unge med autisme uden samtidig intellektuel funktionsnedsættelse.

Denne afgrænsning skyldes formodentlig de vanskeligheder, der er forbundet med at undersøge børn og unge med autisme og samtidig intellektuel funktionsnedsættelse (bl.a. begrænset sprog og eventuel mental retardering). Endvidere kan intellektuel funktionsnedsættelse i sig selv have betydning for sociale relationer, hvorfor det hos personer med autisme og intellektuel funktionsnedsættelse kan være svært at vurdere, i hvilket omfang ensomhed skal ses som en følgevirkning af vanskeligheder forbundet med autisme eller vanskeligheder forbundet med intellektuel funktionsnedsættelse. I denne artikel refereres derfor overvejende til studier af børn og unge med autisme uden samtidig intellektuel funktionsnedsættelse.

Ensomhed

Ensomhed er en subjektiv, ufrivillig og ubehagelig følelse, der opstår som følge af et oplevet modsætningsforhold mellem ønskede sociale relationer og faktiske sociale relationer (Peplau & Perlman, 1982; Pepleau, Miceli & Morasch, 1982; Rotenberg, 1999). Endvidere skelnes mellem emotionel ensomhed, der forårsages af savnet af tætte og intime tilknytningsfigurer og social ensomhed, der er forårsaget af savnet af meningsfulde sociale kontakter og et tilgængeligt socialt netværk (Weiss, 1973). Forbigående følelser af ensomhed anses som naturlige og potentielt motiverende for typisk udviklede børn

og unge (Parker & Asher, 1993), mens vedvarende ensomhed øger risikoen for en række negative forhold (Lasgaard & Friis, 2015; Madsen & Lasgaard, 2014).

Følelsen af ensomhed kan opstå, når man er alene og savner social kontakt og nærhed, men også når man er omgivet af andre mennesker (Lasgaard & Friis, 2015). Det er derfor vigtigt at skelne mellem ensomhed, der bl.a. afspejler kvaliteten af social kontakt og det at være social isoleret/alene, som er et objektivt forhold, der defineres af kvantiteten af den enkeltes sociale relationer (Heinrich & Gullone, 2006). Set i det perspektiv kan børn og unge med autisme føle sig ensomme blandt andre, hvis de ikke oplever et socialt tilhørsforhold til dem, de er sammen med, ligesom de kan være isolerede uden at føle sig ensomme, såfremt den manglende kontakt ikke er forbundet med sociale savn og eksempelvis skyldes et ønske om at være alene. Det afgørende er således den enkeltes sociale behov og opfattelse af egne sociale relationer – for at føle sig ensom må man føle et savn (Kasari & Sterling, 2014).

Venskaber

De sociale vanskeligheder, der karakteriserer børn og unge med autisme, berører centrale og tidligt udviklede sociale funktioner, fx social opmærksomhed og evnen til at dele oplevelser og glæde med andre samt evnen til at forstå intentionalitet og indgå i et gensidigt kommunikativt samspil med andre (Trillingsgaard, 2008). Selvom børn og unge med autisme uden intellektuel funktionsnedsættelse ofte kan løse op-

gaver med social-kognitive elementer i test-situationer, hvor de instrueres i opgaven, ses der ofte problemer i forhold til den spontane anvendelse af sådanne færdigheder (Senju, 2013). De har således vanskeligt ved at overføre deres viden til naturlige hverdagssituationer, hvilket skaber udfordringer for dem i deres sociale samspil med jævnaldrende. Det kan bl.a. være vanskeligt for dem at aflæse andres følelser, hvorfor de ofte befinder sig i situationer, hvor de oplever at have sagt eller gjort noget forkert uden at vide hvorfor. Børn og unge med autisme kan også have svært ved at reagere passende på andres følelser, selv om de er i stand til at identificere dem (Loveland, 2005). Dette kan bl.a. vanskeliggøre muligheden for at etablere gensidigt tilfredsstillende sociale relationer (Travis & Sigman, 1998). Samtidig peger en række studier på, at kognitive færdigheder hos personer med autisme kan kompensere for sociale vanskeligheder gennem observation, analyse og imitation af jævnaldrende, opsætning af enkle regler (Attwood, 2014; Elmose, 2010) eller ved langsomt at opbygge en teoretisk forståelse af egne og andres indre mentale tilstande (Hill, Berthoz & Frith, 2004). Især piger beskrives som relativt avancerede i deres kompenserende strategier (Attwood, 2014).

Under alle omstændigheder kan disse karakteristika i de sociale interaktioner hæmme etableringen af tilfredsstillende relationer mellem børn og unge med autisme og jævnaldrende. De fleste børn med autisme uden intellektuel funktionsnedsættelse har en social tilknytning til deres klasse og

kan udpege en bedste ven (Kasari & Sterling, 2014), men har væsentligt færre gensidige venskaber end typisk udviklede børn (Chamberlain, Kasari & Rotheram-Fuller et al., 2007; Kasari et al., 2011). Børn og unge med autisme har generelt færre venner end typisk udviklede børn og unge og kvaliteten af deres venskaber beskrives tilsvarende lavere (Bauminger & Kasari, 2000; Bauminger, Shulman & Agam, 2003; Bauminger, Shulman & Agam, 2004; Bauminger et al., 2008a; Bauminger, Solomon, Aviezer, Heung, Brown & Rogers, 2008b). Andelen af selvrapporterede venner falder med alderen, og i den sene ungdom og i voksenlivet angiver næsten hver anden med autisme, at de ikke har nogen venner (Kasari & Sterling, 2014). Denne udvikling kan afspejle ændringer i opfattelsen af venskaber snarere end antallet af venner og kan dermed være et udtryk for en stigende opmærksomhed på egne sociale relationer i ungdomsårene (Kasari & Sterling, 2014).

Sammenfattende tydeliggør studier, at børn og unge med autisme har tendens til at være mere socialt isolerede end typisk udviklede jævnaldrende. Spørgsmålet er imidlertid om børn og unge med autisme, som har svage relationer eller er egentligt isolerede, oplever et socialt afsavn eller er tilfredse med deres sociale liv – og om deres kognitive og emotionelle vanskeligheder hæmmer dem i forhold til at forstå og opleve en kompleks følelse som ensomhed.

Forekomst og forståelse af ensomhed

Flere nyere studier har undersøgt forekomsten af ensomhed hos børn og unge med autisme uden intellektuel funktionsnedsættelse. Studierne viser samstemmende, at forekomsten af ensomhed (særligt social ensomhed) er markant større blandt børn og unge med autisme sammenlignet med typisk udviklede jævnaldrende (Bauminger & Kasari, 2000; Bauminger, Shulman & Agam, 2003; Bauminger, Shulman & Agam, 2004; Whitehouse, Durkin, Jaquet & Ziatas, 2009; Lasgaard, Nielsen, Eriksen & Goossens, 2010; Locke, Ishijima, Kasari & London, 2010). Eksempelvis fandt et dansk studie af 39 unge specialskoleelever med autisme (alle drenge), at 21 % ofte eller altid følte sig ensomme mod kun 4 % blandt jævnaldrende drenge fra grundskoler (Lasgaard et al. 2010).

Men forstår børn og unge med autisme ensomhed på samme måde som typisk udviklede børn og unge? Undersøgelser viser, at de fleste børn og unge med autisme uden intellektuel funktionsnedsættelse har en god forståelse af ensomhed, da de typisk forstår, at man kan føle sig ensom blandt andre mennesker, og at en nær ven kan modvirke ensomhed, ligesom de kan give specifikke eksempler på situationer, hvor man kan føle sig ensom (Bauminger & Kasari, 2000). Deres forståelse af ensomhed er dog generelt mindre fyldestgørende og sammenhængende sammenlignet med typisk udviklede jævnaldrende (Bauminger & Kasari, 2000; Bauminger et al., 2003). Børn og unge med autisme har samtidig en bedre forståelse af social ensomhed end af

emotionel ensomhed, hvilket kan skyldes deres vanskeligheder i forhold til at forstå følelser (Bauminger & Kasari, 2000).

Børn og unge opbygger og udvikler løbende deres sociale kompetencer i samspil med andre og forbedrer derved deres muligheder for at forstå og håndtere forskelligartede problemstillinger. Børn og unge med autisme risikerer derfor at ende i en ond cirkel, hvor de fastholdes i uønsket social isolation, hvis de mangler de nødvendige færdigheder til at etablere venskaber. Det er således en særlig belastning for børn og unge med autisme, der er ramt af vedvarende ensomhed, at deres vanskeligheder kan hæmme deres muligheder for at ændre på deres situation.

Kognitive færdigheder hos børn og unge med autisme – herunder udvikling af indsigt i egne og andres mentale tilstande – kan som nævnt være med til at kompensere for sociale vanskeligheder (Elmose, 2010). De samme færdigheder antages imidlertid også at kunne fremme følelsen af ensomhed (Capps, Sigman & Yirmiya, 1995). Selvevaluering og social sammenligning formodes generelt at have stor betydning for oplevelsen af ensomhed (Goossens, 2006). At kunne vurdere og erkende mangler ved egne sociale relationer, herunder at sammenstille egne oplevelser med de oplevelser man tror, at andre har, kan både skabe mulighed for at ændre adfærd, men kan samtidig forstærke oplevelsen af at være anderledes og forkert og fremme en opmærksomhed på sociale vanskeligheder. Øget selvbevidsthed hos voksne med autisme har været koblet til øget grad af depressive symptomer (Hill, Berthoz

& Frith, 2004) og blandt børn med autisme er en relativ høj grad af indsigt i egne og andres mentale tilstande associeret med en negativ vurdering af egne sociale kompetencer, trods forældres positive vurdering af de sociale kompetencer (Capps, Sigman & Yirmiya, 1995). Selvbevidsthed kan også bevirke, at børn og unge med autisme giver sig selv en del af ansvaret for den uønskede sociale situation. Såfremt man erkender, at man ikke har de fornødne sociale færdigheder (Kasari & Sterling, 2014) og samtidig ikke ser nogen forandringsmuligheder, kan det påvirke ens motivation for aktivt at forsøge at ændre den sociale situation. Dermed forstærkes den sociale isolatation og risikoen for langvarig ensomhed øges. Da selvbevidsthed antages at kunne fremme følelsen af ensomhed, er det sandsynligt, at børn og unge med autisme ofte vil opleve ensomhed senere end typisk udviklede børn og unge (Kasari & Sterling, 2014).

Den høje forekomst af ensomhed hos børn og unge med autisme står i kontrast til tidligere opfattelser af, at personer med autisme ikke er socialt motiverede, men derimod foretrækker at være alene. Som Baumeister og Leary (1995) påpeger, er det en forudsætning for følelsen af ensomhed, at man har et socialt ønske og er motiveret for social interaktion. Ud fra dette perspektiv kan ensomhed hos denne delgruppe med autisme tolkes som et udtryk for social motivation og manglende tilfredsstillelse af sociale behov. Samtidig er det vigtigt at holde for øje, at ensomhed langt fra er et problem for alle børn og unge med autisme. Hovedparten er ikke ensomme (Lasgaard et al.,

2010). Om dette skyldes et omfattende netværk, nære relationer, manglende behov for social kontakt/nærhed eller andre forhold er ikke veldokumenteret og vil formodentligt variere fra person til person. Dette understreger relevansen af at spørge børn og unge med autisme – tålmodigt og nysgerrigt – til deres sociale behov og ønsker. Og ikke bero sig på simpel observation.

Sammenfattende er ensomhed hos børn og unge med autisme et reelt problem, som fagpersoner og forældre bør forholde sig til. Vores viden om følger-virkninger af ensomhed blandt børn og unge med autisme er desværre begrænset, men studier med typisk udviklede børn og unge har identificeret en række negative konsekvenser heriblandt dårlig skoleformåen og øget risiko for symptomer på depression (Madsen & Lasgaard, 2014). Der er derfor god grund til at tage ensomhed alvorligt. I det følgende belyses pædagogiske og psykologiske indsatser, der kan være virksomme i arbejdet med ensomhed hos børn og unge med autisme uden samtidig intellektuel funktionsnedsættelse.

Pædagogiske og psykologiske indsatser

Mange børn og unge med autisme har brug for hjælp til at indgå i sociale samspil med jævnaldrende. Vores viden om institutionelle forholds betydning for ensomhed er begrænset, men det er velkendt, at de ydre rammer har betydning for, om børn og unge med autisme kan skabe mening i sociale situationer og være i stand til at deltage i social interaktion (Kasari, Locke, Gulsrud og Rotheram-Fuller, 2011).

Børn og unge med autisme udfordres især i ustrukturerede sociale situationer, fx frikvarterer, som de kan finde overvældende og angstfremkaldende, hvilket bl.a. kan bevirke at de trækker sig fra socialt samvær (Kasari et al., 2011). Andre børn og unge kan misforstå denne tilbagetrukne adfærd som et signal om, at de ikke ønsker at deltage i fællesskabet. En mulighed er her at skabe rammer, der støtter børn og unge med autisme i at skabe mening i de sociale situationer (Kasari et al., 2011). Eksempelvis kan frikvarterer organiseres så særlige interesseområder anvendes som ressource med henblik på at styrke socialisering. Koegel, Vernon, Koegel, Koegel og Paullin (2012) giver et eksempel på et barn med autisme, som er meget optaget af bestemte tegneseriefigurer og brætspil. Ved at skabe en social spilleklub, hvor børnene spiller med figurerne, integreres barnets interesser i socialt attraktive aktiviteter. De strukturerede rammer for socialt samvær kompenserer for barnets sociale vanskeligheder og giver overskud til at være i relationen med andre jævnaldrende. Barnet er på hjemmebane i en aktivitet, som han/hun er god til og som andre jævnaldrende finder interessant. Derved styrkes mulighederne for at etablere sociale relationer, som i bedste fald kan overføres til andre aktiviteter. I tråd med dette case-eksempel anbefaler Zook (2013) systematisk træning af lærere med henblik på at give dem kompetencer til at støtte elever med autisme i at deltage socialt i klassen på en meningsfuld måde.

Der findes en række studier, der har belyst effekten af social færdigheds-

træning og resultaterne herfra har relevans i forhold til forebyggelse og afhjælpning af ensomhed hos børn og unge med autisme. Gruppebaseret social færdighedstræning vil typisk bestå af struktureret undervisning i specifikke færdigheder, rollespil og diskussion med jævnaldrende med samme funktionsniveau. De behandlede emner varierer efter alder og funktionsniveau, men omhandler ofte social-kognitive færdigheder, som fx social problemløsning, genkendelse af følelser og social engagement. En metaanalyse viser, at børn og unge med autisme, der deltager i gruppebaseret social færdighedstræning: a) udvikler deres sociale færdigheder, b) opnår bedre venskaber og c) oplever mindre ensomhed (Reichow et al. 2012). En sidegevinst ved denne type intervention er, at deltagerne hører om andres vanskeligheder og eventuelt erfarer, at der er andre som har det svært socialt, føler sig anderledes og er ensomme.

Udfordringen ved denne type intervention er imidlertid at generalisere de tillærte sociale færdigheder. Deltagerne kan lære om konkrete sociale færdigheder og bruge deres viden i grupperegime, men vil ofte have vanskeligt ved at overføre det lærte til sociale situationer i deres hverdag (DeRosier et al., 2011). I tråd hermed har et litteraturstudie fundet, at langtidseffekten af social færdighedstræning er lille (Bellini et al, 2007). Generalisering af tillærte færdigheder kan derfor med fordel understøttes ved at involvere forældre (Bauminger, 2007), som bl.a. kan fremme træning af nye færdigheder i hjemmet (DeRosier et al., 2011). Forældre kan ikke opfylde deres børns be-

hov for social kontakt med jævnaldrende, men kan støtte deres børn i at skabe og bevare et socialt netværk ved bl.a. løbende at tage initiativ til social kontakt og hjælpe med at strukturere sociale aktiviteter (Lasgaard et al., 2010). Dermed styrkes muligheden for at overføre tillærte sociale færdigheder til naturlige omgivelser i hjemmet og uden for skolen. Forældres aktive involvering kan samtidig fremme deres tillid til, at de kan støtte deres børn i sociale situationer (DeRosier et al., 2011). Endelig tyder et nyere studie på, at det er virksomt at give typisk udviklende jævnaldrende medansvar for at inddrage og støtte børn med autisme uden intellektuel funktionsnedsættelse i sociale aktiviteter (Kasari, Rotheram-Fuller, Locke og Gulsrud, 2012). Studiet fandt, at en kort intervention rettet mod klassekammerater øgede antallet af venskabsnomineringer, forbedrede sociale færdigheder (lærer-rapporteret) og mindskede isolation i frikvarterene hos en gruppe børn med autisme.

Det er sandsynligvis ikke kun mangel på sociale færdigheder, der gør det svært for nogle børn og unge med autisme at danne og vedligeholde tilfredsstillende sociale relationer. Manglende strategier til at håndtere egen stress og angst (emotionel regulering) kan lede til fravalg af social deltagelse, ligesom mangelfulde strategier til håndtering af vrede og aggressiv adfærd kan påvirke mulighederne for samvær med andre, eksempelvis i kraft af andres aktive fravalg. Helhedsorienterede indsatser, der favner både social adfærd og emotionel regu-

lering og som har potentiale til at skabe ændringer i forhold til bagvedliggende mekanismer er derfor ønskværdige.

Sammenfatning

Sammenfattende tyder studier på, at forekomsten af ensomhed er høj blandt børn og unge med autisme uden intellektuel funktionsnedsættelse. Dette indikerer, at der eksisterer en delgruppe med sociale behov, der ikke tilfredsstilles af deres aktuelle relationer. Sociale vanskeligheder, som gør det svært at etablere og fastholde venskaber, kan tilsyneladende ikke alene medvirke til isolation, men også til ensomhed. Det er derfor i pædagogisk psykologisk praksis essentielt at være opmærksom på denne problematik, så isolation og social tilbagetrukkethed ikke automatisk tolkes som et ønske om at være alene. Der er væsentlig forskel på ikke at *ønske* social kontakt og ikke at have *evnerne* til at etablere den.

Vores viden om hvilke interventioner, som er effektive i forhold til afhjælpning af ensomhed hos børn og unge med autisme, er begrænset. Studier tyder dog på, at børn og unge med autisme, der deltager i gruppebaseret social færdighedstræning opnår bedre venskaber og oplever mindre ensomhed. Det er imidlertid en udfordring for deltagerne at generalisere de tillærte sociale færdigheder til andre sammenhænge, og det vil derfor ofte være relevant at kombinere denne type intervention med involvering af forældre og/eller typisk udviklede klassekammerater.

Referencer

- Anderson, D.K., Oti, R.S., Lord, C. & Welch, K. (2009) Patterns of growth in adaptive social abilities among children with autism spectrum disorder. *Journal of Abnormal Child Psychology*; 37(7): 1019–1034.
- Attwood, T. (2014). Behavioral Interventions for Peer Relationships and Emotions. In McPartland, J.C., Klin, A. & Volmar, F.R. (Eds.) *Asperger Syndrome. Assessing and treating high-functioning autism spectrum disorders*. Second ed. The Guildford Press. New York.
- Baumeister, R. F., & Leary, M. R. (1995). The need to belong: Desire for interpersonal attachments as a fundamental human motivation. *Psychological Bulletin*, 117(3), 497-529.
- Bauminger, N., & Kasari, C. (2000). Loneliness and friendship in high-functioning children with autism. *Child Development*, 71(2), 447-456.
- Bauminger, N., Shulman, C., & Agam, G. (2003). Peer interaction and loneliness in high-functioning children with autism. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 33(5), 489-507.
- Bauminger, N., Shulman, C., & Agam, G. (2004). The link between perceptions of self and of social relationships in high-functioning children with autism. *Journal of Developmental and Physical Disabilities*, 16(2), 193-214.
- Bauminger, N. (2007). Group Social-Multimodal Intervention for HFASD. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 37, 1605-1615.
- Bauminger, N., Solomon, M., Aviezer, A., Heung, K., Gazit, L., Brown, J., & Rogers, J. S. (2008a). Children with autism and their friends: A multidimensional study of friendship in high-functioning autism spectrum disorder. *Journal of Abnormal Child Psychology*, 36(2), 135-150.
- Bauminger, N., Solomon, M., Aviezer, A., Heung, K., Brown, J., & Rogers, J. S. (2008b). Friendship in high-functioning children with autism spectrum disorder: Mixed and non-mixed dyads. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 38(7), 1211-1229.
- Bellini, S., Peters, J., Benner, L., & Hopf, A. (2007). A meta-analysis of school-based social skill interventions for children with autism spectrum disorders. *Remedial and Special Education*, 28, 153-162.
- Capps, L., Sigman, M., & Yirmiya, N. (1995). Self-competence and emotional understanding in high-functioning children with autism. *Development and Psychopathology*, 7(1), 137-149.
- Chamberlain, B., Kasari, C., & Rotheram-Fuller, E. (2007). Involvement or Isolation? The Social Networks of Children with Autism in Regular Classrooms. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 37(2), 230-242.
- Christensen DL, Baio J, Braun KV, et al. (2016). Prevalence and Characteristics of Autism Spectrum Disorder Among Children Aged 8 Years — Autism and Developmental Disabilities Monitoring Network, 11 Sites, United States, 2012. *MMWR Surveill Summ* 2016;65(No. SS-3)(No. SS-3):1–23.
- DeRosier, M. E., Swick, D. C., Davis, N. O., McMillen, J. S., & Matthews, R. (2011). The efficacy of a social skills group intervention for improving social behaviors in children with high functioning autism spectrum disorders. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 41(8), 1033-1043.
- Elmose, M. (2010). Autisme spektrum forstyrrelse i et udviklingsperspektiv. *Psyke & Logos*, 31. 417-442.
- Goossens, L. (2006). Affect, emotion, and loneliness in adolescence. In S. Jackson (Red.). *Handbook of Adolescent development* (pp. 51-70). Psychology Press. New York.
- Heinrich, L. M. & Gullone, E. (2006). The clinical significance of loneliness: A literature review. *Clinical Psychology Review*, 26(6), 696-718.
- Hill, E. Berthoz & Frith, U. (2004). Cognitive processing of own emotions in individuals with autistic spectrum disorder and in their relatives. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 34, 229-235.
- Kasari, C., Locke, J., Gulsrud, A., & Rotheram-Fuller, E. (2011). Social networks and friendships at school: Comparing children with and without ASD. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 41(5), 533-544.
- Kasari, C., Rotheram-Fuller, E., Locke, J. og Gulsrud, A. (2012). Making the connection: randomized controlled trial of social skills at school for children with autism spectrum disorders. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 53(4), 431-439.

- Koegel, L. K., Vernon, T. W., Koegel, R. L., Koegel, B. L. & Paullin, A. W. (2012). Improving Social Engagement and Initiations Between Children With Autism Spectrum Disorder and Their Peers in Inclusive Settings. *Journal of Positive Behavior Interventions*, 20(10).
- Kasari, C., & Sterling, L. (2014). Loneliness and social isolation in children with autism spectrum disorders. In R. J. Coplan & J. C. Bowker (Eds.), *The Handbook of Solitude: Psychological Perspectives on Social Isolation, Social Withdrawal, and Being Alone* (pp. 409-426). New York, John Wiley.
- Lasgaard, M. & Friis, K. (2015) Ensomhed i befolkningen – forekomst og metodiske overvejelser. Temaanalyse, vol. 3, Hvordan har du det?, Aarhus: CFK – Folkesundhed og Kvalitetsudvikling.
- Lasgaard, M., Nielsen, A., Eriksen, M. E., & Goossens, L. (2010). Loneliness and social support in adolescent boys with autism spectrum disorders. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 40(2), 218-226.
- Locke, J., Ishijima, E. H., Kasari, C., & London, N. (2010). Loneliness, friendship quality and the social networks of adolescents with high-functioning autism in an inclusive school setting. *Journal of Research in Special Educational Needs*, 10(2), 74-81.
- Loveland, K. A. (2005). Social-emotional impairment and self-regulation in autism spectrum disorders. In J. Nadal, & D. Muir (Red.), *Emotional Development* (pp. 165-382). Oxford University Press.
- Madsen, K. R. & Lasgaard, M. (2014). Ensom, men ikke alene: Viden om et ungdomsproblem. I *En antologi om unge og ensomhed*. s. 10-36. Ventilen.
- Peplau, L. A., Miceli, M., Morasch, B. (1982). Loneliness and Self-Evaluation. In L. A. Peplau & D. Perlman. (Red.), *Loneliness: A sourcebook of current theory, research and therapy* (pp. 135-151). John Wiley & Sons.
- Peplau, L. A. & Perlman, D. (1982). Perspectives on Loneliness. In L. A. Peplau & D. Perlman. (Red.), *Loneliness: A sourcebook of current theory, research and therapy* (pp. 1-18). John Wiley & Sons.
- Reichow, B., Steiner, A. M. & Volkmar, F. (2012). *Social skills groups for people aged 6-21 with autism spectrum disorders (ASD) (Review)*. The Cochrane Collaboration. John Wiley & Sons.
- Rotenberg, K. (1999). Childhood and adolescent loneliness: an introduction. In K. Rotenberg & S. Hymel (eds). *Loneliness in childhood and adolescence* (pp. 3-10). Cambridge University Press.
- Senju, A. (2013). Atypical development of spontaneous social cognition in autism spectrum disorders. *Brain and Development*; 35(2):96-101.
- Travis, L. L., & Sigman, M. (1998). Social deficits and interpersonal relationships in autism. *Mental Retardation and Developmental Disabilities Research Reviews*, 4(2), 65-72.
- Trillingsgaard, A. (2008). Tidlig autisme i 0-12-måneders-alderen. *Psyke & Logos*. Dansk psykologisk forlag.
- Weiss, S. R. (1973). *Loneliness: The Experience of Emotional and Social Isolation*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Whitehouse, A. J. O., Durkin, K., Jaquet, E. og Ziatas, K. (2009). Friendship, loneliness and depression in adolescents with Asperger's Syndrome. *Journal of Adolescence*, 32, 309-322.
- World Health Organization. (1994). *WHO ICD-10: Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser: Klassifikation og diagnostiske kriterier [WHO ICD-10: Mental disorders and behavioural disorders: Classification and diagnostic criteria]*. Copenhagen, Denmark: Munksgaard.
- Zook, S. (2013). *Supporting Social Skills of Adolescents with Autism Spectrum Disorder in the General Education Environment*. California State University, San Marcos.